

## 1 薬剤の分類マップ

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 細胞障害性抗がん薬<br>DNA合成・細胞分裂を障害           | AC・EC療法 (ドキシソルピシン) (エピルピシン) (シクロホスファミド)<br>タキサン系 (パクリタキセル) (ドセタキセル) その他 (カペシタビン) (S-1) (エリブリン)                                            |
| 内分泌療法(HR陽性)<br>エストロゲンの作用を遮断          | 抗エストロゲン薬・SERD (タモキシフェン) (フルベストラント) (イムルネストラント) (カミゼストラント)<br>アロマターゼ阻害薬 (アナストロゾール) (レトロゾール) (エキセメスタン)<br>CDK4/6阻害薬(併用) (パルボシクリブ) (アベマシクリブ) |
| 抗HER2療法<br>HER2シグナルを遮断               | 抗HER2抗体 (トラスツズマブ) (ペルツズマブ) 抗体薬物複合体(ADC) (T-DM1) (T-DXd)<br>HER2チロシンキナーゼ阻害薬 (ラパチニブ) (ツカチニブ)                                                |
| その他の標的薬・免疫療法<br>遺伝子変異・PD-L1・TROP2を標的 | mTOR・AKT阻害薬(併用) (エベロリムス) (カビバセルチブ) PARP阻害薬(BRCA変異) (オラパリブ)<br>ICI(トリプルネガティブ) (ペムブロリズマブ)<br>TROP2標的ADC (ダトボタマブ デルクステカン) (サシツズマブ ゴビテカン)     |

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

## 2 治療ラインの位置づけ(転移・再発乳がん)

| 対象             | 1次治療                                  | 2次治療                                                       | 3次治療以降                                         |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| HR陽性<br>HER2陰性 | ● 内分泌療法(アロマターゼ阻害薬・フルベストラント)+CDK4/6阻害薬 | ● フルベストラント+カビバセルチブ<br>● ESR1変異では経口SERD<br>● gBRCA変異ではオラパリブ | ● 化学療法<br>● T-DXd(HER2低発現)<br>● ダトボタマブ デルクステカン |
| HER2陽性         | ● トラスツズマブ+ペルツズマブ+タキサン                 | ● T-DXd                                                    | ● T-DM1<br>● ツカチニブ+トラスツズマブ+カペシタビン 等            |
| トリプルネガティブ      | ● 化学療法±ペムブロリズマブ(PD-L1陽性)              | ● サシツズマブ ゴビテカン<br>● 化学療法<br>● オラパリブ(gBRCA変異)               | ● T-DXd(HER2低発現)<br>● エリブリン 等                  |

● 細胞障害性抗がん薬中心 ● 分子標的薬(注射)を含む ● 経口薬を含む ● 免疫チェックポイント阻害薬

早期乳がんの術後:HR陽性は内分泌療法5~10年(高リスクはアベマシクリブ2年、gBRCA変異はオラパリブ1年を追加)、HER2陽性はトラスツズマブ±ペルツズマブ1年(術前治療後に残存病変があればT-DM1)。

## 3 副作用の特徴と発現時期

|                    | 投与日          | 1週 | 2週 | 1か月             | 3か月   | 1年~ |
|--------------------|--------------|----|----|-----------------|-------|-----|
| ● インフュージョンリアクション   | ● 初回投与中~24時間 |    |    |                 |       |     |
| ● 悪心・嘔吐(AC/EC療法)   | ● ~5日        |    |    |                 |       |     |
| ● 下痢(アベマシクリブ)      | ● 開始後1週以内に多い |    |    |                 |       |     |
| ● 好中球減少(化学療法)      | ● 7~14日目     |    |    |                 |       |     |
| ● 関節痛(アロマターゼ阻害薬)   |              |    |    | ● 開始後数か月        |       |     |
| ● 心機能低下(抗HER2療法)   |              |    |    | ● 定期的に心エコー      |       |     |
| ● 間質性肺疾患(T-DXd)    |              |    |    | ● 数週~数か月、時期を問わず |       |     |
| ● 骨密度低下(アロマターゼ阻害薬) |              |    |    |                 | ● 年単位 |     |

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

### 押さえておきたいポイント

1. 乳がんはサブタイプ(HR・HER2)で治療体系が決まり、HER2低発現という新しい区分も登場
2. CDK4/6阻害薬は薬剤で副作用が異なる(パルボシクリブ=好中球減少、アベマシクリブ=下痢)
3. 年単位の内分泌療法は薬局が支える。継続の妨げになる副作用の聴取と、病院との情報共有が鍵